

# Uretrograma retrógrado (RUG)

WARWIKI

Información para el paciente · Qué esperar antes de su radiografía de la uretra

Un uretrograma retrógrado — o “RUG” — es una prueba corta de radiografía que toma imágenes de su uretra, el conducto que lleva la orina fuera de su cuerpo. Se coloca con cuidado una pequeña cantidad de tinte dentro de la uretra para que se vea con claridad en la radiografía. Esto ayuda a su cirujano a encontrar y medir cualquier estrechez, cicatriz o lesión antes de planear su tratamiento.

## Acerca de esta prueba

El tejido cicatricial o una estrechez dentro de la uretra — llamada **estrechez uretral** — puede ser difícil de ver en una radiografía común. Un RUG llena el conducto con un tinte especial que se ve blanco en la radiografía. Esto crea un “mapa” claro del interior de su uretra.

### Su cirujano puede pedir un RUG para:

- Encontrar una estrechez o cicatriz y medir exactamente dónde está y qué tan larga es
- Revisar la uretra después de una lesión
- Planear una cirugía para reparar la uretra
- Revisar cómo está sanando la uretra después de una reparación

La prueba muestra el canal abierto dentro de su uretra — el camino que toma la orina. No examina los riñones y no es un tratamiento; es una imagen que guía lo que viene después.

## ¿Es segura?

Sí. Un RUG es una prueba común y de bajo riesgo. La cantidad de radiación que se usa es pequeña, y el tinte es a base de agua y sale de su cuerpo con la orina. La mayoría de las personas solo tienen una molestia breve y leve. Los efectos secundarios poco comunes — una infección de orina, un poco de sangrado o dificultad para orinar por un corto tiempo — suelen ser leves y pasan rápido.

## APRENDA LOS TÉRMINOS

### Uretra

El conducto que lleva la orina desde la vejiga hacia fuera del cuerpo.

### Estrechez uretral

Un punto estrecho o con cicatriz en la uretra que puede hacer más lento o bloquear el flujo de orina.

### Tinte de contraste

Un líquido que se ve blanco en la radiografía para que se pueda ver el interior de la uretra.

### Sonda

Un tubo delgado y blando. Para esta prueba, solo la punta queda apenas dentro de la abertura — no entra por completo.

### Fluoroscopia

Un tipo de radiografía que muestra imágenes en vivo y en movimiento a medida que fluye el tinte.

### Meato

La abertura en la punta del pene por donde sale la orina.

### Urocultivo

Una prueba rápida en una muestra de orina para detectar infección antes de la prueba.

### Urólogo reconstructivo

Un cirujano que se especializa en las vías urinarias y en reparar la uretra.

**¿LE DOLERÁ?** La mayoría de las personas solo sienten una presión o un ardor breve a medida que entra el tinte, no un dolor agudo. El equipo puede ir más despacio en cualquier momento — solo dígales si se siente incómodo. La prueba termina en unos 15–30 minutos.

## Cómo prepararse (antes de su prueba)

Hay muy poco que hacer para prepararse. En la mayoría de los casos:

- Puede **comer y beber normalmente** — no es necesario ayunar a menos que su equipo le indique lo contrario.
- Tome sus **medicinas habituales** a menos que su equipo le pida que suspenda algo.
- Por lo general puede **conducir usted mismo de regreso a casa**, porque la mayoría de los pacientes no necesitan sedación.

### Avisé a su equipo con anticipación si usted:

- Alguna vez ha tenido una reacción al tinte de contraste de radiografía o al yodo
- Toma un anticoagulante
- Tiene señales de una infección de orina (ardor, fiebre, u orina turbia y con olor fuerte) — una infección activa puede hacer que se re programe la prueba

Es posible que le pidan una **muestra de orina** para detectar infección, y puede que le den un **antibiótico** antes o después de la prueba para reducir el pequeño riesgo de infección.

## Qué sucede durante la prueba

- 1 Usted se acuesta en una mesa de radiografía, por lo general girado un poco hacia un lado. El equipo lo ayuda a colocarse.
- 2 Se limpia la punta del pene. Se coloca un tubo pequeño y blando **apenas dentro de la abertura** — solo la punta. Es posible que se infle suavemente un pequeño balón para sostenerlo en su lugar.
- 3 El tinte se coloca lentamente dentro de la uretra mientras se toman las imágenes de radiografía. Es posible que le pidan que se quede quieto y respire normalmente.
- 4 El equipo observa el tinte en una pantalla y toma algunas imágenes desde distintos ángulos. Luego se retira el tubo.

## Después de la prueba

- Por lo general puede irse a casa y volver a sus **actividades normales de inmediato**.
- Puede sentir **un ardor leve al orinar** durante un día más o menos. Beber agua adicional ayuda a eliminarlo y a aliviar esto.
- Puede notar **una pequeña cantidad de sangre** en la punta, o un tono rosado en la orina. Esto es común y por lo general desaparece en un día.
- El tinte sale de su cuerpo con la orina durante las próximas horas.

### Llame a su equipo si tiene:

- Fiebre o escalofríos
- Dificultad para orinar, o no puede orinar en absoluto
- Sangrado abundante, o sangrado que no se detiene
- Dolor que empeora en lugar de mejorar

## TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Un RUG es una radiografía rápida y segura que mapea el interior de su uretra con un tinte especial — ayuda a su cirujano a planear el tratamiento adecuado.
2. Hay poco que hacer para prepararse. Coma, beba y tome sus medicinas habituales — pero avise a su equipo sobre cualquier alergia al tinte, anticoagulantes o señales de una infección de orina.
3. La mayoría de las personas solo sienten una presión breve y se van a casa de inmediato. Un ardor leve o un poco de sangre por un día es normal — beba agua adicional, y llame si tiene fiebre, sangrado abundante o dificultad para orinar.